

Bruxismo, apretamiento y deglución

Tema 9 · Hábitos parafuncionales

Función y parafunción

- La **función** es la actividad con propósito: masticar, deglutir, hablar. Sus contactos son breves e intermitentes, y las fuerzas se distribuyen.
- La **parafunción** es actividad **sin propósito funcional**. Sus contactos son prolongados y sostenidos, con fuerzas mayores y más concentradas.

La diferencia crítica es el tiempo. En masticación los dientes contactan pocos minutos al día; en parafunción pueden contactar horas. Eso es lo que rebasa la capacidad de adaptación.

Bruxismo

Actividad repetitiva de la musculatura masticatoria caracterizada por **apretar o rechinar** los dientes.

Se clasifica por el momento:

- **Bruxismo del sueño**: actividad rítmica, se considera un fenómeno de origen central asociado a microdespertares
- **Bruxismo de vigilia**: predomina el apretamiento, muy ligado a estrés y concentración

Un punto que conviene tener claro: el consenso actual considera el bruxismo un **comportamiento**, no una enfermedad en sí. Puede ser factor de riesgo, y en algunos casos hasta protector frente a la apnea.

Apretamiento y rechinamiento

- **Apretamiento**: fuerza **estática**, sin desplazamiento. Predomina en vigilia. Produce dolor muscular, abfracciones y línea alba en carrillo, pero poco desgaste.
- **Rechinamiento**: fuerza **dinámica**, con movimiento excéntrico. Predomina en sueño. Produce **facetas de desgaste** planas y brillantes que coinciden entre arcadas.

El dato que los diferencia en clínica es el desgaste: si hay facetas coincidentes, hubo movimiento.

Signos a buscar

- Facetas de desgaste que **coinciden** al llevar los modelos a la posición excéntrica
- Hipertrofia maseterina
- Línea alba en la mucosa yugal e indentaciones en el borde lateral de la lengua
- Abfracciones cervicales
- Fracturas de cúspides o de restauraciones repetidas
- Dolor muscular matutino y cefalea al despertar
- Movilidad dentaria sin causa periodontal

El diagnóstico definitivo del bruxismo del sueño requiere polisomnografía; en consulta hablamos de bruxismo **probable** cuando hay signos clínicos más reporte del paciente.

Deglución típica

Es la deglución **madura**, la que se establece tras la transición de la infantil.

Características:

- Dientes en **contacto** durante la deglución
- Punta de la lengua apoyada en la **papila retroincisiva**, detrás de los incisivos superiores
- Contracción de los **elevadores** mandibulares
- **Sin** participación de la musculatura perioral

Se degluten alrededor de 600 a 1000 veces al día, así que un patrón alterado tiene efecto acumulativo importante.

Deglución atípica

Persistencia del patrón infantil más allá de la edad esperada.

Características:

- Lengua **interpuesta** entre las arcadas
- Dientes **sin contacto** al deglutir
- Contracción evidente de la musculatura **perioral**: se ve el mentón arrugado y los labios tensos
- A veces movimiento compensatorio de cabeza

Consecuencias: mordida abierta anterior, protrusión de incisivos, mordida cruzada posterior por falta de estímulo transversal, y recidiva ortodóncica si no se corrige. Suele asociarse a respiración bucal, deglución con biberón prolongada o amígdalas hipertróficas.

Manejo

Para bruxismo y apretamiento:

- Educación y toma de conciencia del hábito
- Higiene del sueño y manejo del estrés
- **Férula de estabilización**, que protege pero no cura el hábito
- Control de factores como cafeína, alcohol, tabaco y ciertos fármacos
- Descartar apnea del sueño cuando hay indicios

Para deglución atípica:

- **Terapia miofuncional** con fonoaudiología
- Corrección de la causa: respiración bucal, obstrucción de vía aérea
- Ortodoncia una vez controlado el hábito, no antes

En ambos casos: si no se controla la causa, la recidiva es cuestión de tiempo.

Este material también está disponible en la plataforma, con ejercicios de autoevaluación por niveles y el asistente académico. **dentipedia.dentilike.com.mx**